CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Observation psychiatrique de suivi du 13/10/2026 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 13/10/2026 à 16:30

Observations :

Vu ce jour à l'antenne de Libourne. 65 ans. A fini la réadaptation respiratoire en juillet, marche 45 minutes par jour, "je n'ai plus le souffle coupé dans l'escalier". Tabac 8 cig/j.
Méthadone 60 mg depuis décembre 2024, pas de manque, pas de mésusage, urines conformes. Oxazépam 20 mg. Pas d'alcool depuis janvier 2024. Douleur 4/10. PPC toutes les nuits.
Thymie bonne. Garde Noé le mercredi. Bénévolat à l'atelier vélo.
Il dresse lui-même le bilan de ces années : "quand je suis arrivé, je comptais les cachets, je trafiquais les ordonnances, je mentais à tout le monde, à vous aussi". Il dit qu'il n'a plus "de secret" dans ce dossier, puis se reprend : "je crois".
Reparle de la baisse de méthadone : accord pour 55 mg/j pendant un mois, puis 50 mg si la douleur le permet, en lien avec le Dr FOURNIOL. Il le dit à sa façon : "on descend l'échafaudage marche par marche".

Conclusions :

- Méthadone gélules 55 mg/j à partir du 20/10, puis réévaluation
- Oxazépam 20 mg
- ECG dans 3 mois
- RDV dans 6 semaines

Note IDE du 15/09/2026 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 15/09/2026 à 09:30

Appel de la pharmacie des Quais : stock de méthadone gélules 60 mg en rupture chez le grossiste pour 48 h, la pharmacie délivre provisoirement des gélules de 40 + 20 mg, dose identique. M. HONTABBAT informé par téléphone, "pas de souci, du moment que c'est la même chose". Transmis au Dr ARRIBEHAUTE.

Observation psychiatrique de suivi du 09/06/2026 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 09/06/2026 à 15:50

Observations :

Vu ce jour. Demande à descendre la méthadone à 50 mg "pour l'anniversaire de mes 6 ans de suivi... enfin 7". Douleur 5/10, réadaptation respiratoire en cours. Discussion : une baisse au moment où la douleur est remontée et en pleine rééducation n'est pas conseillée ; il accepte d'attendre l'automne.
Pas d'alcool, oxazépam 20 mg.

Conclusions :

- RO méthadone gélules 60 mg, oxazépam 20 mg
- Rediscuter la baisse en octobre
- RDV 3 mois

Note IDE du 12/05/2026 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 12/05/2026 à 10:15

ECG de contrôle : QTc 441 ms, transmis. Vient en bus, a commencé la réadaptation respiratoire (3 fois par semaine à Libourne), "épuisant mais ça marche". Toujours 8 à 10 cig/j. Pas de plainte particulière, ordonnance de méthadone renouvelée.

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Observation psychiatrique de suivi du 17/03/2026 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 17/03/2026 à 16:20

Observations :

Vu ce jour. Exacerbation de BPCO début février 2026, traitée à domicile par le Dr FOURNIOL (antibiotique, corticoïdes 5 jours), sans hospitalisation : il avait prévenu lui-même son médecin et sa pharmacie de son traitement de méthadone, "pour ne pas revivre 2021". Récupère, essoufflé au premier étage.
Tabac 10 cig/j, patchs abandonnés. Méthadone 60 mg, oxazépam 20 mg. Pas d'alcool. Douleur 5/10 depuis la bronchite.

Conclusions :

- RO méthadone 60 mg, oxazépam 20 mg
- Réadaptation respiratoire proposée par le pneumologue : encourage
- Nouvelle tentative d'arrêt du tabac avec la tabacologue de l'antenne
- RDV 3 mois

Note IDE du 13/01/2026 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 13/01/2026 à 16:00

RDV de 14 h non honoré. Message de sa fille : il est alité avec une bronchite, a vu le Dr FOURNIOL. Méthadone récupérée par Séverine à la pharmacie avec procuration. Nouveau RDV en février, reporté ensuite au 17/03 à sa demande.

Note IDE du 28/10/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 28/10/2025 à 14:20

Passe à l'antenne pour l'ECG trimestriel (QTc 436 ms) avec des photos : son petit-fils Noé est né le 14/10/2025, "trois kilos deux, il a mes mains". Très ému. A tenu deux semaines avec les patchs puis "repris quelques cigarettes" (6 par jour, jamais dans l'appartement).
Pas d'alcool, même "pour arroser la naissance".

Observation psychiatrique de suivi du 16/09/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 16/09/2025 à 15:40

Observations :

Vu ce jour. Consultation de pneumologie le 02/09 : nouvelle polygraphie (IAH 41), PPC reprise avec un masque narinaire, mieux tolérée, "5 à 6 heures par nuit". Moins de somnolence dans la journée.
Méthadone 60 mg, oxazépam 20 mg depuis mai. Pas d'alcool. Tabac 10 à 12 cig/j, il envisage enfin les patchs "pour le petit".

Conclusions :

- RO méthadone 60 mg, oxazépam 20 mg
- Substituts nicotiniques : patch 21 mg + gommes, prescription faite
- RDV 2 mois

Bilan psychologique du 01/07/2025 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 01/07/2025 à 10:00

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Dernier entretien, bilan de fin de suivi (débuté le 13/04/2021, environ 45 séances).
Motif initial : douleur chronique, perte du rôle professionnel et social après l'accident du travail, histoire familiale. Très vite, le travail s'est centré sur le deuil traumatique de son fils Damien, mort noyé en août 1994, jamais évoqué auparavant avec un soignant, et sur la culpabilité qui s'y attache (il était absent au moment de l'accident). M. HONTABAT a pu relier ce deuil à l'alcool des années 90 et, plus tard, à la place qu'avaient prise les antalgiques : "j'avais mal depuis 1994, le dos m'a donné une raison".
Le décès de son épouse en mars 2022, puis la surdose de mai 2022, ont été une période de grande détresse, avec un épisode dépressif caractérisé et une reprise de l'alcool. Le travail a porté sur le deuil de Mireille, sur les rituels (visite sur la tombe de Damien avec sa fille en août 2022, lettre à Mireille écrite en 2023), et sur la honte (les ordonnances, l'héroïne de 2018, qu'il n'a pu dire qu'à l'infirmière).
Sur le plan de la douleur, l'évolution est parallèle : le dos "fait toujours mal", mais la douleur n'est plus le seul sujet dont il peut parler, ni la seule raison de prendre un traitement. Il formule la différence ainsi : "avant, j'avais mal et je prenais ; maintenant j'ai mal et je fais avec".
Aujourd'hui : thymie stable, pas d'idées suicidaires, activité retrouvée (bénévolat, pétanque), relations apaisées avec sa fille. La culpabilité reste présente mais "elle ne commande plus". Le lac reste un lieu qu'il évite.
Fin du suivi d'un commun accord ; possibilité de reprise à sa demande, en particulier autour de la naissance de son petit-fils ou des dates anniversaires.

Entretien éducatif du 03/06/2025 (Urgence : Bas)

Validé par HAURIE Josselin - Educateur spécialisé le 03/06/2025 à 11:00

Entretien à Libourne. M. HONTABAT donne des nouvelles avec fierté : il est bénévole deux matinées par semaine dans un atelier de réparation de vélos d'une association de quartier, "je ne porte rien, j'explique aux jeunes". Il se rend à l'atelier à pied. Le club de pétanque l'a nommé "responsable du terrain".
Il prépare la chambre "du petit" (naissance prévue en octobre) chez lui pour les gardes.
Plus de besoin d'accompagnement éducatif régulier : clôture, RDV à sa demande.

Synthèse annuelle du 15/04/2025 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 15/04/2025 à 18:00

Observations :
Synthèse annuelle (6 ans de suivi).
Rappel du parcours : 64 ans, maçon puis chef de chantier, AT le 14/10/2013 (chute d'un échafaudage, fracture de L1, arthrodèse puis reprise en 2015), invalidité en 2016, retraite en 2023. Veuf depuis le 12/03/2022. Un fils, Damien, décédé en 1994. Vit à Libourne depuis septembre 2024 près de sa fille Séverine.
Addictions : TUO sur oxycodone (2015-2019, jusqu'à 300 mg/j, deux prescripteurs, ordonnances falsifiées, héroïne fumée brièvement en 2018, surdose en 2018), sous méthadone depuis juin 2019 : 60 mg, puis 80, 100, de nouveau 80 après la surdose du 21/05/2022, 70 mg en 2023 (QTc), gélules depuis 06/2024, 60 mg depuis 12/2024. Prégabaline mésusée, arrêtée en 2023. TUAL ancien sevré en 1999, reprise en 2022, rechute à Noël 2023, abstinent depuis le 06/01/2024. Oxazépam 30 mg. Tabac 12 cig/j.
Psychiatrie : épisode dépressif caractérisé 2022-2024, en rémission, duloxétine arrêtée en 12/2024. Deuil compliqué travaillé en psychothérapie.
Somatique : BPCO GOLD 2, SAOS sévère (PPC abandonnée en 2023, à relancer), HTA, lombalgies chroniques 4-5/10.
Événements de l'année écoulée : installation à Libourne (09/2024), arrêt de la duloxétine sans rechute, baisse de la méthadone à 60 mg, Noël passé chez sa fille sans alcool. Le suivi psychologique, hebdomadaire au moment des deuils, est espacé à une fois par mois.
Ce jour : bien, "la meilleure année depuis l'accident". Marche une demi-heure par jour, pétanque deux fois par semaine.

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Douleur 4/10 malgré la baisse de la méthadone. Pas de manque. Urines conformes. QTc 438 ms en mars.
Pas d'alcool, éthylotest 0. Thymie bonne, sommeil correct mais fatigue dans la journée.
Il dit avoir trouvé à Libourne "une vie de quartier" qu'il n'avait plus à Cenon depuis l'accident ; voit sa fille presque tous les jours. Il parle de Mireille au passé sans pleurer, et de Damien "plus facilement qu'avant". Aucune demande d'antalgique en dehors du paracétamol.

Conclusions :
- RO méthadone gélules 60 mg
- Oxazépam : réduction à 20 mg/j, accepte
- Nouvelle demande de rendez-vous en pneumologie (PPC, BPCO)
- Fin du suivi psychologique à discuter avec Mme LAPEYRADE
- RDV 3 mois

Note IDE du 11/02/2025 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 11/02/2025 à 16:30

RDV non honoré à l'antenne de Libourne. Joint au téléphone : il garde son petit voisin malade, "j'ai complètement oublié". Pas de plainte, pas de manque à 60 mg, Noël "passé sans un verre". Nouveau RDV le 25/02.

Observation psychiatrique de suivi du 17/12/2024 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 17/12/2024 à 16:10

Observations :
Vu ce jour à Libourne. Duloxétine 30 mg depuis octobre sans rechute dépressive : arrêt ce jour. Pas d'alcool, ira chez Séverine à Noël "pour la journée, puis je rentre".
Demande une diminution de la méthadone : "je veux finir avec moins". Douleur stable. Après discussion, passage à 60 mg/j.

Conclusions :
- Méthadone gélules 60 mg/j à partir du 20/12
- Arrêt de la duloxétine
- Oxazépam 30 mg, réduction à proposer ensuite
- RDV 2 mois

Entretien téléphonique du 22/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 22/10/2024 à 11:45

Appel de la pharmacie des Quais (Libourne) : l'ordonnance sécurisée reçue mentionne encore l'ancienne pharmacie de Cenon. Nouvelle ordonnance faite par le médecin du CSAPA avec le bon nom de pharmacie, envoyée. Pas d'autre problème, le patient "très courtois".

Observation psychiatrique de suivi du 08/10/2024 (Urgence : Bas)

Validé par CAZENAVETTE Corentin - Interne le 08/10/2024 à 15:30

Observations :
Vu ce jour à l'antenne de Libourne.
S'installe, fait les courses à pied, "plus de marche qu'à Cenon". Douleur 5/10. Méthadone gélules 70 mg, délivrées par la

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

pharmacie des Quais depuis le 05/09. Pas d'alcool. Thymie correcte, "je dors mieux depuis que je vois ma fille tous les jours".
Demande d'arrêter la duloxétine ("je vais bien, je veux moins de médicaments").
Conclusions :
- Duloxétine diminuée à 30 mg, arrêt à discuter en décembre avec le Dr ARRIBEHAUTE
- RO méthadone 70 mg, oxazépam 30 mg
- RDV décembre (fin de mon semestre)

Entretien social du 10/09/2024 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 10/09/2024 à 14:00

Entretien à l'antenne de Libourne du CSAPA.
M. HONTABAT a déménagé le 01/09/2024 dans un appartement au rez-de-chaussée (T2 avec un petit jardin), 11 allée des Sarments, 33500 LIBOURNE, à 10 minutes à pied de chez sa fille. Maison de Cenon vendue en juin. Même numéro de portable.
Démarches faites : changement d'adresse auprès de la caisse de retraite et de la CPAM, transfert de l'aide à domicile (1 h par semaine désormais), carte de bus. Nouveau médecin traitant : Dr Perrine FOURNIOL (Libourne), déclaration faite.
Pharmacie : pharmacie des Quais (Libourne), protocole méthadone à transmettre.
Le déménagement a été organisé avec son gendre et deux anciens collègues de pétanque. Il a gardé "trois meubles de Mireille" et a donné le reste à une association. Mireille est enterrée à Cenon : "j'irai à la Toussaint, ma fille m'emmènera".
Il se dit "content et triste" : soulagé de ne plus avoir l'entretien de la maison, mais "j'ai laissé Mireille là-bas". Sans voiture désormais (vendue), il compte sur sa fille et le bus. Inscription au club de pétanque du quartier envisagée.
Suivi social terminé, RDV à la demande.

Délivrance du 02/07/2024 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 02/07/2024 à 10:00

Passage pour un ECG de contrôle après le passage aux gélules : QTc 452 ms. Pas de plainte. Trie ses cartons, "trente ans de vie dans des cartons de bananes". Rappel : apporter le coffret à clé pour les gélules.

Observation psychiatrique de suivi du 18/06/2024 (Urgence : Bas)

Validé par CAZENAVETTE Corentin - Interne le 18/06/2024 à 17:00

Observations :
Vu ce jour. Passage de la méthadone sirop aux gélules à dose égale (70 mg) à partir de ce jour, après avis du Dr ARRIBEHAUTE (stabilité depuis plus d'un an, pas de mésusage de la méthadone).
Rappel du stockage sécurisé (boîte fermée à clé, hors de portée du petit-fils à venir) et de la naloxone.
La vente de la maison est signée, déménagement prévu fin août à Libourne.
Conclusions :
- Ordonnance sécurisée méthadone gélules 70 mg, délivrance 14 jours
- Poursuite du suivi à l'antenne de Libourne du CSAPA après le déménagement
- RDV fin septembre

Observation psychiatrique de suivi du 21/05/2024 (Urgence : Bas)

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Validé par CAZENAVETTE Corentin - Interne le 21/05/2024 à 16:30

Observations :
Vu pour la première fois ce jour (interne du semestre).
Rappel : 63 ans, AT en 2013 (chute d'échafaudage, fracture L1, deux chirurgies), douleur chronique ; TUO sur oxycodone avec nomadisme et falsifications, sous méthadone depuis 2019 ; mésusage de prégabaline (arrêtée en 2023) ; TUAL ancien (sevrage 1999), reprise en 2022 après le décès de l'épouse, rechute à Noël 2023 ; surdose accidentelle en 2023 (réanimation) ; EDC sous duloxétine ; BPCO, SAOS.
Actuellement : méthadone 70 mg, stable, douleur 5/10. Demande à passer aux gélules ("le sirop me donne des caries et c'est lourd à transporter"). Pas d'alcool depuis le 06/01, éthylotest 0. Urines : méthadone +, BZD +, le reste négatif.
Conclusions :
- Accord de principe pour les gélules, à confirmer avec le Dr ARRIBEHAUTE
- RO méthadone 70 mg, oxazépam 30 mg, duloxétine 60 mg
- RDV 1 mois

Entretien psychologique du 12/03/2024 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 12/03/2024 à 10:00

M. HONTABAT revient sur la rechute de Noël sans s'effondrer : "j'ai glissé, je me suis relevé". Il parle davantage de Séverine, qui a "un projet de bébé" avec son mari (parcours de PMA en cours). Il envisage sérieusement de vendre la maison de Cenon pour se rapprocher d'elle. La perspective d'être grand-père lui "donne une raison". Fin d'entretien plus légère.

Note IDE du 13/02/2024 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 13/02/2024 à 09:40

Renouvellement de l'ordonnance sécurisée de méthadone 70 mg (Dr ARRIBEHAUTE), faxée à la pharmacie. Le patient passe la récupérer, dit que "tout va bien depuis Noël", pas d'alcool. Prise de rendez-vous pour l'interne en mai.

Observation psychiatrique de suivi du 09/01/2024 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 09/01/2024 à 15:10

Observations :
Vu ce jour. Rechute d'alcool pendant les fêtes : a commencé le 23/12 "avec une bouteille de vin offerte par un voisin", puis 4 à 5 bières par jour, seul, jusqu'au 06/01. A arrêté de lui-même après avoir fait une chute sans gravité dans l'escalier. Pas de signe de sevrage, éthylotest à 0 ce jour. Honteux, mais en parle spontanément.
Méthadone 70 mg, oxazépam 30 mg, duloxétine 60 mg. Thymie un peu basse, sans idées noires.
Conclusions :
- Pas de modification du traitement, naltrexone proposée, refusée ("encore un cachet")
- Rappel du kit de naloxone et du risque alcool + méthadone
- RDV 1 mois

Entretien psychologique du 07/11/2023 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 07/11/2023 à 10:00

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Entretien difficile : approche des fêtes, "le premier Noël où je comprends vraiment qu'elle n'est plus là" (l'an dernier, "j'étais dans le brouillard"). Il ne veut pas aller chez Séverine : "je ne veux pas gâcher leur Noël". Évoque un rêve récurrent du lac.
Travail sur l'anticipation des moments à risque, la possibilité d'accepter l'invitation pour quelques heures seulement. Il évoque, sans insister, l'envie de "boire un coup pour tenir".
Plan d'action discuté (appel au CSAPA, à sa fille, au collègue de pétanque). Prochain RDV début janvier.

Observation psychiatrique de suivi du 05/09/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 05/09/2023 à 16:00

Observations :
Vu ce jour. Méthadone 70 mg depuis avril, bien tolérée, douleur 5/10, pas de manque.
Repris la confidence faite à l'IDE (héroïne fumée à l'été 2018) : il confirme, soulagé que ce soit dit. Pas d'usage depuis.
Thymie stable, plus d'idées de mort. Sort davantage (pétanque, pêche).
Pas d'alcool. Aide à domicile en place depuis juin.
Conclusions :
RO méthadone 70 mg, duloxétine 60 mg, oxazépam 30 mg
RDV 2 mois

Entretien infirmier du 20/06/2023 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 20/06/2023 à 11:10

Entretien IDE de suivi (prise de sang, ECG). ECG : QTc 455 ms sous 70 mg. Il va "plutôt bien", a passé une semaine chez Séverine.
On parle de la surdose de l'an dernier et du kit de naloxone (toujours dans le tiroir de l'entrée, pas périmé). Il me dit alors, à voix basse, "je vous ai jamais dit, mais l'été 2018 j'ai pris de l'héroïne". Quand l'oxycodone manquait, en juillet-août 2018, un neveu de sa femme lui en a procuré : il l'a fumée "sur du papier alu", "5 ou 6 fois, pas plus", jamais injectée. Il a arrêté quand il a trouvé le second médecin. Il n'en a parlé à personne, "même pas à la psy", "c'est le truc dont j'ai le plus honte". Pas de consommation depuis.
Je l'ai rassuré sur la confidentialité, il accepte que je le transmette au Dr ARRIBEHAUTE.
Tabac 15 cig/j, toujours pas de PPC.

Synthèse annuelle du 18/04/2023 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 18/04/2023 à 18:30

Observations :
Synthèse du suivi, 4 ans après l'entrée au CSAPA (15/04/2019).
Biographie : 62 ans, né à Cenon, maçon puis chef de chantier dans la même entreprise de 1977 à l'accident du travail, invalidité en 2016, retraité depuis le 01/03/2023. Marié en 1984 avec Mireille, décédée le 12/03/2022 d'un cancer du pancréas. Deux enfants : Séverine (1986), à Libourne, et Damien, mort noyé en 1994 à 4 ans (révélé en 2021 seulement, deuil traumatique). Vit seul à Cenon.
Douleur : chute d'un échafaudage le 14/10/2013 (4 m d'après le CETD), fracture de L1, arthrodèse T12-L2 le 16/10/2013, reprise le 09/06/2015. Lombalgies et radiculalgie droite chroniques, 5-6/10.
Opioïdes : tramadol 2013-2015, oxycodone de 2015 à juin 2019 avec escalade jusqu'à 280-300 mg/j, fentanyl transdermique 2017-2018 ; second prescripteur à Lormont de 2017 à 2019 et une quinzaine d'ordonnances falsifiées en 2018-2019 ; rappel à la loi en mars 2019. Surdose en novembre 2018 (révélée par sa fille en 2022). Rotation vers la

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

méthadone en hospitalisation en juin 2019 (60 mg), 80 mg en 09/2019, 100 mg en 06/2020 ; rechute brève d'oxycodone en septembre 2020 ; syndrome de sevrage sévère en décembre 2021 (méthadone omise en pneumologie) ; surdose accidentelle le 21/05/2022 (méthadone fractionnée + prégabaline + oxazépam + alcool), réanimation puis unité d'addictologie ; méthadone ramenée à 80 mg.
Prégabaline : mésusage 600-900 mg/j de 2019 à 2021, décroissance, arrêt le 06/02/2023.
Alcool : TUAL des années 90 après le décès de son fils, sevrage hospitalier en 1999, abstinence jusqu'en 2022 ; reprise en avril 2022 après le décès de son épouse, sevrage ambulatoire en septembre 2022, abstinent depuis.
Benzodiazépines : alprazolam 2014-2019, oxazépam depuis 06/2019, 30 mg/j actuellement.
Psychiatrie : épisode dépressif caractérisé depuis mai 2022, en amélioration partielle sous duloxétine 60 mg.
Somatique : BPCO GOLD 2 (exacerbation hospitalisée en décembre 2021), SAOS sévère appareillé en 2020 (la PPC n'est plus mise depuis l'hiver : "le tuyau me réveille"), HTA, tabac 15 cig/j.
Cette année : ECG du 11/04/2023, QTc 472 ms (méthadone + duloxétine), kaliémie normale.
Ce jour : thymie nettement améliorée, reprise d'un rythme de vie (jardin, pétanque, pêche en projet), plus d'idées de mort. Pas d'alcool depuis septembre (éthylotest 0, GGT 31). Pas de manque sous méthadone 80 mg, douleur 5/10. Il dit de ces quatre années : "je suis arrivé ici pour la justice, je reste pour moi".

Conclusions :
- Méthadone réduite à 70 mg/j (accepte, "si c'est pour le cœur"), ECG dans 1 mois
- Duloxétine 60 mg poursuivie, oxazépam 30 mg
- Relance PPC avec le pneumologue
- Poursuite psychologue, IDE, assistante sociale

Entretien social du 14/03/2023 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 14/03/2023 à 10:30

Reprise de contact à la demande de M. HONTABAT.
Passage à la retraite le 01/03/2023 (62 ans) : la pension d'invalidité est remplacée par la pension de retraite pour inaptitude, la rente AT (30 %) est maintenue. Dossier complet, premiers versements en avril. Pension de réversion de son épouse demandée (refusée, plafond de ressources dépassé : recours non conseillé).
Revenus stables. Charges de la maison trop lourdes à entretenir seul (jardin, toiture à refaire). Il parle pour la première fois de vendre la maison "un jour", pour se rapprocher de Séverine à Libourne, mais "pas tant qu'il y a Mireille dans chaque pièce".
Isolement : sort peu en dehors de la pétanque le jeudi, mange seul. Le dimanche chez sa fille "quand elle n'est pas de garde" (Séverine est infirmière). Pas de voisinage proche en dehors du voisin qui l'a trouvé en mai dernier et avec qui il "boit le café, rien d'autre". Proposition d'aide à domicile (2 h par semaine) via la caisse de retraite : dossier déposé.
Information sur le portage de repas, refusé ("je sais faire cuire un steak").
A revoir dans 6 mois.

Note IDE du 14/02/2023 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 14/02/2023 à 10:30

Passage pour le bilan sanguin. Prégabaline arrêtée le 06/02/2023 comme prévu : "deux nuits un peu agitées, c'est tout". Pas de reprise. Méthadone 80 mg, pas de plainte. Pense à la retraite qui arrive le 1er mars.

Note IDE du 10/01/2023 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 10/01/2023 à 17:20

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

RDV médical de 14 h 30 non honoré. Pas de réponse au téléphone. Appel de la pharmacie du Bois-Fleuri à 16 h : M. HONTABAT est passé ce matin chercher sa méthadone, "il allait bien, il partait à la pêche avec un ami". Message laissé. Rappelle à 17 h, s'excuse, "j'ai confondu avec la semaine prochaine". Nouveau RDV pris pour le 24/01.

Entretien éducatif du 06/12/2022 (Urgence : Bas)

Validé par HAURIE Josselin - Educateur spécialisé le 06/12/2022 à 14:00

Point sur ses journées depuis l'été : lever 8 h, jardin ou bricolage le matin, pétanque le jeudi avec deux anciens collègues, déjeuner chez Séverine le dimanche. Le soir reste "le moment dur", il a mis la radio "pour qu'il y ait une voix". Pas d'alcool à la maison. Projet : reprendre la pêche au printemps.

Observation psychiatrique de suivi du 08/11/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 08/11/2022 à 16:30

Observations :
Vu ce jour. Pas d'alcool depuis le 12/09 d'après lui, GGT 48. Thymie améliorée, a renoué avec deux anciens collègues du club de pétanque. Pense moins à Mireille "le matin", toujours le soir.
Prégabaline 225 mg/j depuis octobre, puis 150 mg/j, sans difficulté. Méthadone 80 mg. Douleur 5/10. Oxazépam 30 mg.
Conclusions :
- Poursuite de la décroissance de prégabaline : 75 mg/j en décembre, arrêt prévu début 2023
- RO méthadone 80 mg, duloxétine 60 mg, oxazépam 30 mg
- RDV 2 mois

Observation IDE du 27/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 27/09/2022 à 12:05

Dernier passage à domicile pour le sevrage (commencé le 12/09). Pas de signe de sevrage depuis le début, juste "des nuits plus longues", pas d'alcool selon lui et selon Séverine (qui vérifie les placards, il en rit). Ethylotest à 0. TA 138/82. Oxazépam 30 mg/j depuis hier, bien.
Il m'a montré la cabane qu'il refait au fond du jardin "pour le futur petit-enfant, un jour". Il met la PPC "3 ou 4 nuits par semaine", c'est mieux qu'avant. Il me demande si les "groupes d'alcooliques" servent à quelque chose : renseignements donnés sur les groupes du CSAPA et les associations d'entraide.

Observation psychiatrique de suivi du 13/09/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 13/09/2022 à 15:20

Observations :
Vu ce jour, avec Séverine en fin d'entretien.
Thymie un peu meilleure sous duloxétine 60 mg : mange mieux, a repris le jardin, est allé sur la tombe de son fils avec sa fille en août.
Mais reprise de l'alcool depuis fin juillet "à petites doses" : 3 à 5 verres de vin le soir, parfois plus le dimanche, éthylotest positif ce jour (0,22 mg/L à 15 h). Séverine a retrouvé des bouteilles. Il dit vouloir arrêter "avant que ça recommence comme en 1994". Séverine, présente en fin d'entretien, est soulagée qu'il en parle lui-même ; elle propose de passer chaque soir pendant le sevrage. Pas d'antécédent de complication de sevrage connu en dehors de 1999 ("j'avais tremblé, c'est tout").

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

Méthadone 80 mg, prégabaline 300 mg, oxazépam 40 mg.

Conclusions :

- Sevrage ambulatoire de l'alcool du 12/09 au 23/09 : oxazépam majoré à 60 mg/j sur 4 jours puis décroissance jusqu'à 30 mg/j, passages IDE (Mme BIROT) à J1, J3, J7
- Thiamine 250 mg/j
- Prégabaline : décroissance à 225 mg/j après le sevrage
- RDV 1 mois

Entretien psychologique du 05/07/2022 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 05/07/2022 à 10:00

Reprise après la surdose. M. HONTABAT dit avoir "deux morts sur le dos et une à moitié ratée". Il parle de Mireille avec beaucoup de tendresse et de culpabilité : les dernières semaines où il "était défoncé au Lyrica" pendant qu'elle était malade, ce qu'il n'a pas su lui dire.

Il fait lui-même le lien entre le décès de Damien en 1994 et la reprise de l'alcool : "c'est la même chose, j'ai bu pour ne pas entendre le silence".

Il dit que la surdose lui a fait "honte devant Séverine" plus que peur pour lui-même, et qu'il a compris en réanimation qu'elle "aurait perdu les trois". Il évoque pour la première fois l'envie de "faire quelque chose de propre" des années qui restent.

Travail sur les rituels de deuil : il n'est jamais retourné sur la tombe de Damien depuis l'enterrement. Il évoque l'idée d'y aller avec Séverine.

Thymie encore basse mais "un peu de goût" pour le jardin. Pas d'idées suicidaires. Poursuite toutes les 2 semaines.

Observation psychiatrique de suivi du 07/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 07/06/2022 à 16:00

Observations :

Vu au CSAPA, sorti de l'unité le 03/06/2022 après 10 jours.

Méthadone 80 mg, peu de manque, "le soir c'est un peu long". Duloxétine 60 mg depuis le 03/06. Prégabaline 300 mg. Oxazépam ramené à 40 mg/j.

Pas d'alcool depuis le 21/05. Séverine a vidé le garage des bouteilles. Kit de naloxone à la maison, Séverine et le voisin formés.

Accepte un passage IDE à domicile une fois par semaine pendant un mois et l'éducateur pour "remettre de la vie dans la journée".

Conclusions :

- Méthadone 80 mg, délivrance à 7 jours
- Duloxétine 60 mg, prégabaline 300 mg, oxazépam 40 mg
- Psychologue toutes les 2 semaines
- RDV 1 mois

Observation IDE de nuit du 01/06/2022 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 02/06/2022 à 06:00 par SOUBIRON MATHÉO

Patient calme. A mis la PPC sans difficulte apres explication, l'a gardee jusqu'a 4h puis retiree ("le masque me serre"). SpO2 90-92 % sous PPC. Pas de sueurs, pas de tremblements. Se leve a 5h, fume a la fenetre de la salle commune, recadre gentiment. Dit "je n'ai pas bu depuis 10 jours, c'est la premiere fois depuis Mireille".

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Observation psychiatrique de suivi du 31/05/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 31/05/2022 à 18:00

Observations :

Entretien dans l'unité d'addictologie (entré le 24/05 après la réanimation).

Repris l'appel de sa fille. Il confirme la surdose de novembre 2018 : "à l'époque je prenais tout ce que je trouvais, oxycodone, les patchs, le Lyrica". Il l'avait tue à l'entrée au CSAPA "parce que ça aurait fait de moi un drogué pour de bon".

Alcool : reconnaît avoir recommencé à boire début avril 2022, environ trois semaines après les obsèques. "D'abord un verre le soir pour dormir", puis vin rouge au repas et pastis l'après-midi, 6 à 8 verres par jour, en cachette de sa fille. Craving le soir, "le silence de la maison". Pas de signe de sevrage alcoolique à l'entrée dans l'unité (oxazépam en cours), CDT 2,4 %, GGT 112.

Thymie : tristesse permanente, anhédonie, perte d'appétit (-6 kg depuis mars), culpabilité massive (Damien, Mireille, "et maintenant Séverine qui me retrouve à moitié mort"), insomnie, ralentissement. Idées de mort passives ("si je ne me réveillais pas ce ne serait pas grave"), pas de scénario. Il parle de ses soirées depuis le décès : il ne met plus la table, mange devant la télévision, "boit un coup" puis prend "un peu de méthadone" gardée du matin et "deux ou trois Lyrica" pour dormir. Il ne mettait plus la PPC. Il n'avait pas compris que l'association pouvait l'arrêter de respirer : "je croyais que c'était le cœur qui lâche, pas les poumons".

Episode dépressif caractérisé, d'intensité moyenne à sévère, réactionnel au deuil, sur un terrain de deuil traumatique ancien.

Douleur 6/10. SpO2 nocturne 85 % sans PPC.

Conclusions :

- Méthadone réduite à 80 mg/j en une prise le matin, plus de fractionnement (QTc 451 ms)
- Prégabaline 300 mg/j strict (150 x 2), distribuée, plus aucune autre source
- Oxazépam maintenu à 50 mg/j pendant le séjour (couvre le sevrage d'alcool), à réduire ensuite
- Duloxétine 30 mg, 60 mg dans 10 jours (antidépresseur, effet sur les douleurs neuropathiques)
- Kit de naloxone nasale, formation du patient et de sa fille
- Reprise de la PPC dans le service
- Psychologue et éducateur informés

Entretien téléphonique du 27/05/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 27/05/2022 à 15:20

Appel de Mme Séverine LAPÈGUE, fille de M. HONTABAT, qui souhaite parler à l'équipe (son père hospitalisé à l'unité a donné son accord pour qu'on échange avec elle).

Elle est très en colère et très inquiète : "ce n'est pas la première fois". En novembre 2018, sa mère avait retrouvé son père "tout bleu" dans la chambre un matin ; le SAMU était venu, piqûre (elle pense que c'était de la naloxone), il avait passé une nuit aux urgences, et "le lendemain il était à la maison comme si de rien n'était". Ses parents lui avaient fait promettre de n'en parler à personne. Elle pensait que les médecins le savaient.

Elle dit aussi que depuis la mort de sa mère, son père "boit en cachette" : bouteilles de vin et de pastis dans le garage, au moins depuis Pâques, elle l'avait trouvé "pas net" plusieurs fois au téléphone le soir.

Elle demande s'il peut "rester plus longtemps à l'hôpital". Explications données sur l'hospitalisation en cours, le kit de naloxone qui lui sera proposé. Elle souhaite venir à un RDV. Transmis au Dr ARRIBEHAUTE.

Entretien téléphonique du 24/05/2022 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 24/05/2022 à 11:30

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Observations :

Appel du service de réanimation du CHU (médecin de l'unité). M. HONTABAT a été admis le samedi 21/05/2022 au soir : retrouvé inconscient dans son fauteuil par son voisin, qui s'inquiétait de ne pas le voir sortir son chien. Bradypnée à 6/min, myosis serré, SpO2 70 %. Naloxone par le SMUR avec réveil partiel, puis perfusion de naloxone pendant 18 h. Pneumopathie d'inhalation traitée.

Toxiques : méthadone (taux élevé pour 100 mg), prégabaline, oxazépam, et alcoolémie à 1,6 g/L à l'admission. Pas d'oxycodone ni d'autre opioïde.

Son voisin a trouvé sur la table du salon une bouteille de vin entamée et une plaquette de Lyrica presque vide ; le flacon de méthadone de la semaine contenait moins que prévu. Le SMUR a apporté les boîtes.

Le patient décrit une soirée "comme les autres" : son flacon de méthadone du soir (il avait pris l'habitude de couper la dose en deux, "pour dormir"), "quelques" Lyrica, et "du vin avec le repas". Il nie toute intention suicidaire et l'équipe de réanimation ne retient pas de geste volontaire (pas de lettre, pas de propos suicidaires, regrets spontanés).

Sortie de réanimation ce jour.

Conclusions :

- Transfert dans l'unité d'addictologie organisé dès cet après-midi (place libre)
- Je le vois dans l'unité

Observation psychiatrique de suivi du 12/04/2022 (Urgence : Bas)

Validé par SENTUCQ Apolline - Interne le 12/04/2022 à 16:45

Observations :

Vu ce jour, un mois après le décès de son épouse.

Vit seul dans la maison, Séverine passe le week-end. "Tout me rappelle Mireille, même le bruit du frigo." Sommeil très haché, pas de PPC depuis le décès. Mange peu. Pleurs. Ruminations sur Damien et Mireille, "maintenant je suis le seul qui reste".

Pas d'idées suicidaires actives, "je n'ai pas le droit, pour Séverine".

Dit ne pas boire d'alcool. Pas d'oxycodone. Prégabaline 375 mg, méthadone 100 mg.

Odeur d'alcool ? Pas certaine, pas d'éthylotest (refusé "par principe" : "vous me prenez pour un ivrogne").

Conclusions :

- Proposition d'antidépresseur, refusée pour le moment ("je ne suis pas fou, je suis triste")
- Rapprocher les RDV psychologue
- RDV dans 15 jours, fin de mon semestre : relais au Dr ARRIBEHAUTE

Entretien téléphonique du 15/03/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 15/03/2022 à 10:15

M. HONTABAT appelle pour annuler son RDV de jeudi : son épouse Mireille est décédée samedi 12/03 à la maison, "elle n'a pas souffert à la fin". Obsèques vendredi à Cenon. Voix très lente, longues pauses, mais cohérent. Sa fille est avec lui.

Je lui demande s'il a son traitement : oui, flacon pour 14 jours, il "ne fera pas de bêtise". Rappel du numéro du CSAPA et des urgences. Proposé de passer la semaine prochaine, il préfère "après l'enterrement". Transmis au Dr ARRIBEHAUTE et à l'interne, qui le rappellera.

Note IDE du 15/02/2022 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 15/02/2022 à 12:10

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Appel de M. HONTABAT pour décaler son RDV de la semaine prochaine : Mireille est en HAD, "ça se rapproche", il ne veut pas la laisser. Proposé une consultation téléphonique avec l'interne, accepté. Ordonnance de méthadone à jour jusqu'au 10/03.

Observation psychiatrique de suivi du 04/01/2022 (Urgence : Bas)

Validé par SENTUCQ Apolline - Interne le 04/01/2022 à 15:40

Observations :
Vu ce jour, sorti de pneumologie le 17/12/2021 sous corticoïdes et antibiotiques. Encore fatigué, oxygène non nécessaire.
Garde un vif souvenir du sevrage ("j'ai cru que j'allais mourir, je ne veux plus jamais vivre ça"), en colère contre l'hôpital.
Carte de traitement remise, à garder dans le portefeuille.
Mme HONTABAT en soins palliatifs à domicile depuis Noël, HAD. Séverine vient tous les deux jours.
Méthadone 100 mg, prégabaline 375 mg (la décroissance prévue à 300 est repoussée par le patient), oxazépam 50 mg.
Tabac 10 cig/j depuis l'hospitalisation.
Conclusions :
- RO méthadone 100 mg, prégabaline 375 mg, oxazépam 50 mg
- Prévenu qu'il peut appeler en dehors des RDV
- RDV 1 mois

Entretien téléphonique du 14/12/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SENTUCQ Apolline - Interne le 14/12/2021 à 13:10

Observations :
Appel du service de pneumologie du CH (interne de garde du week-end puis médecin du service) : M. HONTABAT est hospitalisé depuis le 08/12 pour une exacerbation de BPCO (surinfection bronchique, SpO2 84 % aux urgences). Son traitement de méthadone n'avait pas été prescrit à l'entrée (flacon resté à domicile, traitement non retrouvé dans le logiciel de la pharmacie hospitalière) : aucune prise pendant 48 h.
Le 10/12, syndrome de sevrage sévère : vomissements, diarrhée, sueurs profuses, tachycardie à 120, agitation, douleurs diffuses, a voulu partir contre avis médical. Méthadone reprise le 10/12 au soir après appel de sa fille, 50 mg puis 100 mg dès le 11/12, avec amélioration en 24 h.
Transmis : posologie exacte (100 mg/j), délivrance par la pharmacie du Bois-Fleuri, prégabaline 375 mg/j et oxazépam 50 mg/j, à poursuivre.
Joint ensuite le patient au téléphone : fatigué, encore nauséeux, très en colère ("ils m'ont laissé crever deux jours"). Il dit qu'il a pensé à "sortir acheter n'importe quoi" mais qu'il était trop faible. Réassurance, rappel qu'il peut demander à l'équipe de nous appeler.
Conclusions :
Retour prévu en fin de semaine. Revoir à la sortie.

Observation psychiatrique de suivi du 09/11/2021 (Urgence : Bas)

Validé par SENTUCQ Apolline - Interne le 09/11/2021 à 16:20

Observations :
Vu pour la première fois ce jour.
Rappel : 60 ans, ancien chef de chantier, AT avec fracture lombaire (arthrodèse 2013, reprise 2015), TUO sur oxycodone (jusqu'à 300 mg/j, falsification d'ordonnances, deux prescripteurs) sous méthadone depuis 06/2019 ;

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

mésusage de prégabaline découvert en septembre ; TUAL ancien sevré en 1999 ; deuil d'un fils en 1994.
Prégabaline 375 mg/j depuis le 14/10, tolère, "un peu plus de nervosité le soir". Méthadone 100 mg.
Fatigue +++ (s'occupe de Mme, chimio tous les 15 jours). Thymie basse, pleurs, sommeil 4 h, PPC "quand j'y pense".
Pas d'idées suicidaires.
Toux et dyspnée majorées depuis 2 semaines, tabac remonté à 20 cig/j.
Conclusions :
- RO méthadone 100 mg, prégabaline 375 mg
- Conseille de reconsulter le MT pour la toux
- RDV 1 mois

Observation psychiatrique de suivi du 14/09/2021 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 14/09/2021 à 17:10

Observations :
Vu ce jour, seul. Effondré : son épouse Mireille a appris fin août un cancer du pancréas avec métastases hépatiques, chimiothérapie débutée. Il l'accompagne aux séances, "c'est à mon tour de m'occuper d'elle".
Abordé le résultat des urines du 07/09 (prégabaline à un taux très élevé) et les flacons de Lyrica que Mme a trouvés dans le garage et dont elle a parlé à l'oncologue. Il reconnaît prendre 600 à 900 mg/j de prégabaline "depuis au moins deux ans", soit depuis 2019, au lieu des 300 mg prescrits. Il complète avec des boîtes achetées "à un gars sur le parking du centre commercial", ou de vieilles ordonnances du CETD. "Ça me calme le dos et la tête." Il dit en avoir pris davantage depuis l'annonce du cancer de Mireille, jusqu'à "6 gélules de 150 certains soirs". Somnolence, deux chutes à la maison cet été, qu'il attribuait "au dos".
Méthadone 100 mg, pas d'oxycodone. Alcool : "rien", GGT 36.
Conclusions :
- Prégabaline : plan de décroissance, prescription unique par le CSAPA, délivrance à 7 jours : 450 mg/j pendant 1 mois puis 375 mg/j
- RO méthadone 100 mg, oxazépam 50 mg
- Soutien, proposition d'entretien avec sa fille
- RDV 3 semaines avec l'interne qui arrive en novembre si besoin

Entretien social du 22/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 22/06/2021 à 14:30

RDV à sa demande : il veut savoir si la visite médicale du permis de conduire est obligatoire "avec la méthadone", car son permis arrive à renouvellement de la catégorie poids lourd (qu'il voudrait garder "par fierté").
Au cours de l'entretien, il explique qu'il "connaît déjà la commission médicale" : en 1998 il a eu une suspension de permis de 6 mois pour conduite en état d'ivresse, contrôlé au retour d'un chantier, avec une amende et un passage devant la commission pour récupérer le permis. Il ne l'avait pas mentionné à l'accueil ("on ne m'a demandé que la justice de maintenant").
Information donnée : la méthadone n'interdit pas la conduite mais doit être signalée au médecin agréé ; la somnolence liée aux apnées doit être traitée d'abord. Il renonce au poids lourd.
Pas d'autre démarche.

Entretien psychologique du 08/06/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 08/06/2021 à 10:00

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

4e entretien. Séance très chargée émotionnellement.
M. HONTABAT dit d'emblée qu'il "ne m'a pas tout dit". Il n'a pas eu "une fille", mais deux enfants : Séverine, et un garçon, Damien, né en 1990, mort noyé à 4 ans, au mois d'août 1994, dans le lac de baignade où la famille passait le dimanche. Il était "à la buvette avec les copains" à ce moment-là. Il se dit responsable depuis 27 ans : "si j'avais été là". Mireille ne l'a jamais accusé, "c'est pire".
Il relie lui-même la suite : après le décès, il s'est mis à boire "pour ne plus voir le lac", d'abord le soir puis dès le matin, jusqu'à la clinique de 1999 où il est allé "pour ne pas perdre Mireille et Séverine". Il n'en a jamais parlé à aucun médecin : "on ne parle pas de ça".
A l'accueil et chez le médecin il avait dit avoir une seule fille : "c'est plus simple, sinon on pose des questions".
Il pleure longuement, s'excuse. Pas d'idées suicidaires actuelles, mais dit avoir "pensé à partir" plusieurs fois dans les années 90.
Il décrit l'enterrement, le petit cercueil blanc, puis "le silence à la maison" les mois suivants : Mireille ne parlait plus, Séverine, alors âgée de 8 ans, "faisait comme si de rien n'était". Il est retourné au travail au bout de trois jours, "parce qu'au chantier on ne pense pas".
Ce deuil non élaboré semble central, y compris dans la façon de vivre la douleur ("j'ai mal au dos depuis 1994, en fait").
Avec son accord, information transmise au Dr ARRIBEHAUTE. Poursuite toutes les 3 semaines, travail sur le deuil.

Entretien psychologique du 13/04/2021 (Urgence : Bas)

Validé par LAPEYRADE Maïwenn - Psychologue le 13/04/2021 à 10:00

Premier entretien. M. HONTABAT arrive en avance, s'assied droit, parle d'abord du dos, longtemps, de façon très précise (les vis, les radios, "le chirurgien m'a dit que j'avais des os de jeune homme"). La douleur est le seul sujet "autorisé" au début de l'entretien.
Puis il évoque l'après-accident : la perte du statut de chef de chantier, "les gars qui m'appelaient chef", la honte de ne plus pouvoir porter les sacs de courses, le sentiment d'être "un meuble" à la maison. Sa femme "fait tout". Il dit avoir pris les comprimés "pour pouvoir faire semblant d'être encore debout".
A propos de l'alcool des années 90, il dit seulement "il y a eu des années noires", sans s'étendre. Beaucoup de retenue émotionnelle, les yeux qui se remplissent quand il parle de son père, "un dur".
Il décrit sa journée type : lever tard, télévision, une courte marche avec le chien, la sieste, "attendre le soir". Sa femme et sa fille sont les seules personnes qu'il voit régulièrement ; il a "perdu les copains" en même temps que le chantier.
Proposition : un entretien toutes les 3 semaines, travail autour de la douleur, de la perte du rôle et de l'histoire familiale.
Accepte.

Observation psychiatrique de suivi du 02/03/2021 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 02/03/2021 à 16:40

Observations :
Vu ce jour.
Reçu le courrier du Dr PUYOOU (CETD) daté du 22/02/2021, récapitulatif complet de la prise en charge de la douleur depuis l'accident : dates de l'accident et des deux interventions, périodes de tramadol, d'oxycodone, de fentanyl transdermique (de février 2017 à octobre 2018, et non 6 mois en 2016 comme le patient l'avait dit), prégabaline depuis 2016. Surtout, dans les antécédents relevés par le CETD en 2014 : "sevrage alcoolique hospitalier en 1999, clinique des Pins, Lormont, abstinence depuis".
Repris avec M. HONTABAT, qui avait dit à l'entrée n'avoir "jamais eu de problème avec l'alcool". Il confirme, gêné : "c'était il y a vingt ans, c'est réglé, je ne pensais pas que ça comptait". Il buvait "beaucoup" dans les années 90, du pastis "le matin sur le chantier" à la fin, sa femme avait menacé de partir ; 3 semaines de clinique en 1999 "et plus jamais une goutte d'alcool fort". Depuis, "un verre de vin de temps en temps". Ne dit pas ce qui avait fait basculer ("des

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

soucis de famille").
Pas de consommation actuelle d'alcool évoquant un mésusage, GGT 38 en janvier.
Il dit ne pas l'avoir signalé parce qu'il avait "peur qu'on mette tout dans le même sac : l'alcool, les cachets, la justice". On reprend ensemble ce que le courrier apporte sur les dates de l'accident et des opérations, qu'il donnait de mémoire de façon approximative ("pour moi, l'accident c'est 2014, c'est l'année où j'ai compris que je ne remonterais pas sur un chantier").
Méthadone 100 mg, douleur 6/10. PPC 4 h par nuit.
Conclusions :
- Note au dossier : trouble de l'usage de l'alcool ancien, sévère, en rémission prolongée depuis 1999 ; vigilance
- RO méthadone 100 mg, prégabaline 300, oxazépam 50
- Propose un suivi psychologique (Mme LAPEYRADE) : accepte "pour essayer"
- RDV 2 mois

Note IDE du 05/01/2021 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 05/01/2021 à 11:30

Appel de la pharmacie : ordonnance de méthadone arrivée à échéance le 03/01, le Dr ARRIBEHAUTE en congés. Renouvellement fait par le médecin de permanence du CSAPA, faxé à 11 h. M. HONTABAT prévenu, ira chercher son flacon cet après-midi. RAS par ailleurs, "bonne année à toute l'équipe".

Observation psychiatrique de suivi du 17/11/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 17/11/2020 à 15:00

Observations :
Vu ce jour.
Polygraphie du 13/10/2020 : syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère, IAH 38/h, désaturations jusqu'à 81 %.
Appareillé par PPC le 05/11 par le prestataire, la supporte "à moitié" (masque qui gêne).
EFR : trouble ventilatoire obstructif, VEMS 61 %, BPCO stade GOLD 2. Inhalateur prescrit par le pneumologue (tiotropium). Arrêt du tabac de nouveau conseillé : il réduit "à 15", ne veut pas de patchs.
Pas d'oxycodone depuis le 18/09, urines conformes. Méthadone 100 mg, douleur 6/10. Somnolence diurne moins marquée depuis la PPC, "même si je l'enlève vers 3 h". Ne conduit plus que le matin.
Conclusions :
- Méthadone 100 mg, délivrance 14 jours à nouveau
- Prudence oxazépam et prégabaline avec le SAOS : ne pas augmenter ; expliqué au patient le risque de dépression respiratoire nocturne, il dit "comprendre maintenant pourquoi je me réveillais étouffé"
- Tabac : entretien motivationnel, pas prêt, réévaluer
- Courrier au CETD pour une réévaluation de la douleur et un récapitulatif écrit de leur prise en charge (jamais reçu)

Observation psychiatrique de suivi du 29/09/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 29/09/2020 à 17:30

Observations :
Vu ce jour. Urines du 22/09 positives à l'oxycodone. Reconnaît avoir repris de l'oxycodone "pendant deux semaines", début septembre : un ancien collègue opéré du genou lui a vendu "une boîte et demie" de comprimés à 20 mg qu'il ne prenait plus. Jusqu'à 3 comprimés par jour en plus de la méthadone. Arrêt depuis le 18/09 "parce que la boîte était finie" et "parce que j'ai eu peur en conduisant".

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

Pas de recherche active d'une autre source. Analyse de la situation : douleur plus forte depuis l'été, ennui, sa fille partie en vacances.
ECG de juillet : QTc 448 ms.
Conclusions :
- Méthadone 100 mg maintenue, délivrance repassée à 7 jours
- Polygraphie et EFR enfin programmées en octobre
- RDV kiné relancé, groupe "douleur et mouvement" du CETD proposé
- RDV 1 mois

Note IDE du 08/09/2020 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 08/09/2020 à 16:50

RDV de 14 h non honoré, ni excusé. Appel sur le portable, pas de réponse, message laissé. Rappelle à 16 h 30 : "j'ai oublié, j'étais chez ma fille". Voix pâteuse ? Il dit avoir mal dormi. Nouveau RDV proposé avec le Dr ARRIBEHAUTE le 29/09, accepté.

Observation psychiatrique de suivi du 16/06/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 16/06/2020 à 16:10

Observations :
Vu ce jour, premier RDV en présentiel depuis le confinement.
Douleur en hausse (7/10), radiculalgie droite quotidienne, a pris du poids (98 kg) faute de marcher. Le confinement l'a "rouillé" : plus de pétanque, plus de sorties, sa femme fait les courses seule. Dit avoir "eu envie" d'oxycodone pendant le confinement mais ne pas en avoir pris. Urines du 09/06 : méthadone +, BZD +, oxycodone -.
Somnolence dans la journée, s'endort au volant à l'arrêt ("au feu rouge, une fois") : conduite déconseillée en attendant la polygraphie, jamais faite.
Avis CETD (téléphone, Dr PUYOOU) : pas de reprise d'opioïde antalgique, méthadone à majorer, TENS, kiné.
Conclusions :
- Méthadone majorée à 100 mg/j en une prise, ECG dans 1 mois
- Polygraphie : demande renvoyée au service de pneumologie, avec EFR (toux, dyspnée)
- RDV 1 mois

Entretien téléphonique du 24/03/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 24/03/2020 à 10:20

Observations :
Consultation téléphonique (confinement). Méthadone 80 mg, délivrance en pharmacie passée à 14 jours. Pas de manque. Reste à la maison avec sa femme, "ça ne change pas grand-chose pour moi". Douleur 6/10, marche moins.
Pas de consommation. Rappel des signes de surdosage, conseil de ne pas modifier les prises.
Conclusions :
Ordonnance sécurisée méthadone 80 mg 14 j faxée à la pharmacie
RDV téléphonique dans 1 mois

Entretien social du 25/02/2020 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 25/02/2020 à 11:00

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Jugement du pôle social reçu (délibéré du 14/02/2020) : taux d'IPP porté à 30 % après expertise, rente révisée avec rappel. M. très ému, "on me croit enfin". Explications sur le versement. Dossier ALD déposé avec le médecin traitant. Clôture du suivi social régulier, RDV à la demande.

Entretien éducatif du 18/02/2020 (Urgence : Bas)

Validé par HAURIE Josselin - Educateur spécialisé le 18/02/2020 à 14:00

2e entretien. M. HONTABAT parle plus librement aujourd'hui, en tête à tête ("pas devant le docteur").
Il raconte qu'il n'a pas "corrigé une date une fois" : entre l'été 2018 et janvier 2019 il a fabriqué "une quinzaine" d'ordonnances, en scannant une ordonnance sécurisée de son médecin et en modifiant les quantités et les dates sur l'ordinateur de sa fille, imprimées sur du papier acheté exprès. Il les présentait dans des pharmacies de la rive droite "où on ne me connaissait pas". Celle du Bois-Fleuri l'a repéré en janvier 2019 (numéro de lot du papier), d'où la convocation au commissariat en février et le rappel à la loi.
Il dit avoir agi "comme sur un chantier quand il manque du matériel : on se débrouille", sans se sentir un délinquant sur le moment, et que c'est la convocation au commissariat qui lui a "ouvert les yeux". Dit qu'il en a "encore la nausée" et que sa femme ne sait pas tout. Ne veut pas que le médecin le note "dans les papiers de la justice" : expliqué le secret, il accepte que ce soit transmis à l'équipe.
Travail proposé : budget des journées, occupations, "redevenir quelqu'un d'utile". Il voudrait aider au club de pétanque.

Observation psychiatrique de suivi du 21/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 21/01/2020 à 15:30

Observations :
Vu ce jour. Abordé l'appel du médecin conseil. Silence long, puis reconnaît avoir consulté un second médecin à Lormont "depuis 2017, peut-être fin 2016", sans le dire au Dr CAPDEPUY : "avec le centre de la douleur on ne m'en donnait jamais assez, et j'avais honte de redemander". A l'entrée il avait parlé d'un seul médecin : "je ne voulais pas que ça fasse un dossier de plus".
Pas d'oxycodone depuis juin dit-il, urines conformes. Méthadone 80 mg. Douleur 5-6/10.
Il ajoute que le Dr MANSENCAL "ne posait pas de questions", qu'il y allait "tous les mois, un mardi", et qu'il payait la consultation en liquide pour que sa femme ne voie pas les relevés. Ne dit rien d'autre sur la façon dont il se procurait le reste ; ne parle pas des ordonnances de janvier 2019.
Thymie : honte, mais soulagé "que ce soit sorti". Pas d'idées suicidaires.
Conclusions :
- Protocole de soins CPAM : prescripteur unique (CSAPA pour la méthadone), pharmacie du Bois-Fleuri
- RO méthadone 80 mg, prégabaline 300, oxazépam 50
- Propose des entretiens avec M. HAURIE (éducateur) pour le "travail sur les ordonnances" et la gestion du quotidien

Entretien téléphonique du 07/01/2020 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 07/01/2020 à 12:50

Observations :
Appel du Dr LOUBERE, médecin conseil de la CPAM (Gironde), dans le cadre du contrôle annoncé à M. HONTABAT ; échange limité aux éléments nécessaires, patient prévenu par courrier de la caisse.
Le relevé des remboursements 2017-2019 montre deux prescripteurs d'oxycodone en parallèle : le Dr CAPDEPUY (médecin traitant, Cenon) et un Dr MANSENCAL (Lormont), de début 2017 jusqu'à mars 2019, avec des délivrances dans trois pharmacies différentes. Au total, plus de 250 mg/j d'oxycodone délivrés en moyenne sur 2018, sans compter

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

les ordonnances refusées.
Le Dr MANSENCAL n'était pas au courant des prescriptions du médecin traitant. La caisse ne prévoit pas de poursuite, le patient étant suivi et sous méthadone ; un protocole de soins (prescripteur et pharmacie uniques) lui sera imposé.
Conclusions :
Reprendre avec le patient au prochain RDV (21/01).

Observation psychiatrique de suivi du 10/12/2019 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 10/12/2019 à 16:00

Observations :
Vu ce jour. Stable sous méthadone 80 mg. Attend le délibéré du tribunal. Douleur 5/10, a fait une heure de marche dimanche avec sa femme. Urines conformes. Prégabaline 300 mg déclarés. Tabac 20 cig/j.
Conclusions :
RO méthadone 80 mg
RDV janvier

Entretien social du 26/11/2019 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 26/11/2019 à 10:40

Point après l'audience du 21/11/2019 au pôle social du tribunal judiciaire (contestation du taux d'IPP de 15 % fixé par la caisse). Expertise médicale ordonnée en audience, décision mise en délibéré. M. HONTABAT est déçu ("encore des mois"), mais son avocat est "confiant".
Il a apporté le courrier de la CPAM annonçant un contrôle de ses prescriptions par le service médical : il ne comprend pas pourquoi "maintenant que j'ai tout arrêté". Explication donnée sur le rôle du médecin conseil. A transmettre au Dr ARRIBEHAUTE avec son accord.
RDV en janvier.

Observation psychiatrique de suivi du 15/10/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LABOUYRIE Baptiste - Interne le 15/10/2019 à 17:00

Observations :
Vu ce jour, dernier entretien avec moi (fin de semestre).
Rappel : 58 ans, chute d'un échafaudage fin 2013 (fracture de L1, arthrodèse puis reprise), douleur chronique, oxycodone jusqu'à 300 mg/j, rotation vers la méthadone en juin 2019, rappel à la loi pour ordonnance falsifiée.
Méthadone 80 mg depuis le 10/09 : plus de manque le soir, douleur 5/10, sommeil meilleur. Pas de consommation d'oxycodone rapportée, urines conformes.
Inquiet de l'audience du 21/11 au tribunal ("on va encore me traiter de simulateur"). Thymie un peu basse, pas d'idées noires.
Tabac 20 cig/j, refuse les substituts nicotiniques "pour l'instant".
Conclusions :
- RO méthadone 80 mg
- Le dossier passe au Dr ARRIBEHAUT à partir de novembre
- RDV dans 1 mois

Observation psychiatrique de suivi du 10/09/2019 (Urgence : Bas)

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 10/09/2019 à 14:20

Observations :
Vu ce jour avec son épouse.
Méthadone 60 mg depuis juin, délivrée en pharmacie depuis fin juillet, sans incident. Pas d'oxycodone d'après lui, urines du 03/09 : méthadone +, oxycodone -, BZD +.
Douleur 6/10, la radiculalgie droite "revient le soir". Manque en fin de nycthémère (bâillements, sueurs vers 22 h).
Mme confirme qu'il est "plus présent", "il ne compte plus les cachets".
Prégabaline 300 mg/j, oxazépam 50 mg/j.
Conclusions :
- Méthadone majorée à 80 mg/j
- RO prégabaline, oxazépam
- La polygraphie n'a pas été faite (pas de RDV), relancer
- RDV 1 mois avec l'interne

Délivrance du 02/07/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 02/07/2019 à 09:15

Délivrance méthadone 60 mg. Vient tous les matins depuis la sortie, toujours à l'heure ("le chantier, ça vous apprend"). Se plaint de transpirer beaucoup et d'être constipé : conseils hygiéno-diététiques, macrogol proposé. Fume dehors avant et après. Parle de son petit jardin, dit qu'il a recommencé à tailler la haie "assis sur un tabouret".

Observation psychiatrique de suivi du 25/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 25/06/2019 à 14:30

Observations :
Vu ce jour, 11 jours après la sortie. Délivrance quotidienne au CSAPA. Méthadone 60 mg : manque léger en fin d'après-midi, douleur 6/10. Pas d'oxycodone ("je n'ai plus rien à la maison, ma femme a tout rapporté à la pharmacie").
Urines conformes.
Conclusions :
RO méthadone 60 mg, oxazépam 50 mg, prégabaline 300 mg
Passage en pharmacie fin juillet si stable

Observation psychiatrique de suivi du 14/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LABOUYRIE Baptiste - Interne le 14/06/2019 à 11:40

Observations :
Sortie ce jour après 12 jours. Méthadone titrée jusqu'à 60 mg en une prise, dernière interdose d'oxycodone le 09/06.
Manque résiduel le soir, douleur 5/10 "moins pire qu'avant, c'est bizarre". ECG J5 : QTc 441 ms.
Oxazépam 50 mg/j, prégabaline 300 mg/j. Désaturations nocturnes à 86 % : polygraphie demandée en externe.
Séjour calme après les trois premières nuits, participation aux groupes de l'unité ("je n'ai rien à voir avec eux" le premier jour, puis "on a tous mal quelque part" à la fin). Bonne entente avec l'équipe. Entretien familial le 12/06 avec son épouse : explications sur la méthadone, la délivrance, les risques d'association avec l'alcool et les benzodiazépines.
Conclusions :
- Méthadone sirop 60 mg/j, délivrance au CSAPA les premières semaines puis en pharmacie (Bois-Fleuri)
- Plus de prescription d'oxycodone : courrier au Dr CAPDEPUY et au Dr PUYOOU

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

- Oxazépam 10-10-10-20, prégabaline 150 x 2
- RDV CSAPA le 25/06

Observation IDE de nuit du 05/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé automatiquement le 06/06/2019 à 06:00 par SOUBIRON MATHÉO

Nuit agitee jusqu'a 1h. Se plaint du dos 8/10 et de "fourmis dans les jambes", sueurs, baillements, COWS 12. Interdose oxycodone LI 10 mg a 23h30 selon prescription. Endormi vers 1h30, ronflements +++ avec pauses respiratoires, SpO2 86-88 % pendant le sommeil, remonte a 92 au reveil. Signale au medecin de garde. Methadone 40 mg ce matin a prevoir.

Observation d'entrée en hospitalisation du 03/06/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LABOUYRIE Baptiste - Interne le 03/06/2019 à 18:20

Observations :

Entrée programmée dans l'unité d'addictologie pour rotation oxycodone -> méthadone.

Rappel : 58 ans, chef de chantier en invalidité, chute d'un échafaudage avec fracture lombaire opérée (2 interventions), douleur chronique, oxycodone depuis plusieurs années, rappel à la loi en 2019 pour ordonnance falsifiée.

A l'entretien d'entrée, plus détendu qu'en consultation, et devant la perspective de la méthadone, il revient sur les doses : "160, c'est ce qui est sur l'ordonnance". En réalité il prendrait "entre 280 et 300 mg par jour" depuis l'automne dernier, en ajoutant des gélules à libération immédiate "toutes les trois heures" les mauvais jours. Ne dit pas comment il se procure le surplus ("j'avais des réserves", "des boîtes d'avant"), se ferme quand on insiste. Il dit que depuis le rappel à la loi il a "tout réduit" et qu'il ne lui reste "que ce qu'il y a sur l'ordonnance", d'où des manques fréquents depuis mars. Mme HONTABAT, présente à l'installation, dit qu'il "ne tient plus en place" le soir depuis quelques semaines et qu'il a "maigri du visage".

Prégabaline : 150 x 2 "et parfois un de plus". Alprazolam 0,5 mg x 3.

Dernière prise d'oxycodone ce matin 7 h (80 mg LP + 20 mg LI).

Il dit avoir peur "d'avoir mal comme au début", et peur aussi "qu'on me prenne pour un toxico" dans le service. Il a apporté ses boîtes restantes, comptées et remises à l'équipe (2 boîtes entamées de LP 80 mg, une de LI 20 mg), qu'il demande à ne pas récupérer.

Contexte : son épouse l'a accompagné, elle se dit "épuisée" par les derniers mois, les nuits où il se lève pour "chercher un cachet", les colères quand la pharmacie refuse une délivrance. Le couple tient, "mais il était temps".

Sur le plan douloureux : lombalgies basses permanentes, radiculalgie droite jusqu'au pied, augmentée par la station debout prolongée ; périmètre de marche environ 500 m. Pas de déficit moteur.

Examen : pas de signe de manque à 18 h (COWS 3). Douleur 6/10. SpO2 93 %. Ronflements notés par l'équipe à la sieste.

Conclusions :

- Arrêt de l'oxycodone LP, interdoses d'oxycodone LI 10 mg si besoin (max 4) pendant la titration
- Méthadone sirop 30 mg demain matin, puis augmentation par paliers de 10 mg selon COWS et sédation (surveillance FR, SpO2 la nuit)
- Relais alprazolam par oxazépam 50 mg/j (10-10-10-20)
- Prégabaline 150 mg x 2, distribuée par l'équipe
- ECG à J5, demande de polygraphie à prévoir en externe

Entretien téléphonique du 21/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 21/05/2019 à 09:05

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Appel de la pharmacie du Bois-Fleuri (Cenon) : la pharmacienne veut savoir si M. HONTABAT "est bien suivi chez nous" depuis l'histoire de janvier. Confirmé avec l'accord du patient (consentement signé au dossier). Elle signale qu'il est venu chercher sa boîte d'oxycodone avec 3 jours d'avance la semaine dernière, refusé. Information transmise à l'interne.
Patient rappelé : "je me suis trompé de date", entrée toujours prévue le 03/06.

Observation psychiatrique de suivi du 07/05/2019 (Urgence : Bas)

Validé par LABOUYRIE Baptiste - Interne le 07/05/2019 à 16:30

Observations :
Vu ce jour, premier entretien avec moi. Accepte la rotation vers la méthadone en hospitalisation, après en avoir discuté avec sa femme ("elle dit que c'est la dernière chance").
Bilan : ASAT/ALAT normales, GGT 41, NFS sans particularité. ECG : rythme sinusal, QTc 428 ms.
Dit toujours 160 mg/j d'oxycodone, mais "termine plus tôt" les boîtes de LP. Prégabaline 300 mg/j déclarés. Douleur 7/10.
Le Dr PUYOOU (CETD) a été joint : favorable à la rotation, envoie un courrier récapitulatif "dès que possible".
Conclusions :
- Entrée programmée dans l'unité d'addictologie le 03/06/2019
- Poursuite du traitement actuel d'ici là, sans augmentation
- RDV IDE dans 15 jours

Bilan social du 25/04/2019 (Urgence : Bas)

Validé par MOURGUES Ghislène - Assistante sociale le 25/04/2019 à 15:10

Entretien avec M. HONTABAT, accompagné de son épouse Mme Mireille HONTABAT, restée dans la salle d'attente à sa demande puis invitée à la fin.
Situation familiale : marié, une fille majeure (Séverine LAPÈGUE, Libourne). Le couple vit dans une maison dont il est propriétaire (emprunt soldé), 14 rue des Jonquilles, 33150 CENON. Tél. : 06 82 37 51 46.
Situation professionnelle : maçon puis chef de chantier dans la même entreprise de 1977 à l'accident du travail (chute d'un échafaudage). Arrêt de travail continu, puis consolidation et mise en invalidité catégorie 2 en 2016. Licenciement pour inaptitude la même année.
Ressources : pension d'invalidité + rente AT calculée sur un taux d'IPP de 15 %, que M. conteste ("avec ce que j'ai, 15 %, c'est se moquer du monde"). Recours devant le pôle social du tribunal judiciaire déposé en 2017, audience fixée au 21/11/2019, avocat désigné par le syndicat. Retraite de Mme. Pas de dette, pas de crédit en cours.
Couverture : ALD au titre des séquelles ? À vérifier avec le médecin conseil. Mutuelle d'entreprise maintenue.
Permis de conduire valide, conduit encore "pour les courses".
Justice : rappel à la loi (03/2019), pas d'autre procédure selon lui.
Mme exprime à la fin son inquiétude : "il n'est plus le même depuis l'accident", "il compte ses cachets toute la journée", il dort beaucoup dans la journée et ronfle "à faire trembler les murs". Elle soutient le projet d'hospitalisation.
Vie quotidienne : Mme gère les papiers et le budget depuis l'accident ; M. conduit encore pour les courses mais "évite l'autoroute". Ni aide à domicile ni portage, pas de besoin exprimé. Le couple garde le chien de leur fille le week-end.
Démarches : courrier de soutien pour l'avocat si besoin (avec accord du médecin), point ALD.
A revoir après l'hospitalisation.

Observation médicale d'entrée du 18/04/2019 (Urgence : Bas)

Validé par ARRIBEHAUTE Ombeline - Médecin le 18/04/2019 à 17:45

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND
Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Admission A1904150028
lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits)

Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE
UFM 5208 - CSAP
UFH 5208 - CSAP

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

Observations :

Motif : M. HONTABAT, 58 ans, ancien chef de chantier en invalidité, vient à la suite d'un rappel à la loi (mars 2019) pour une ordonnance d'oxycodone falsifiée repérée par sa pharmacie en janvier. Demande personnelle "d'y voir clair" sur les antalgiques, "mais je ne peux pas arrêter, j'ai trop mal".

Histoire de la douleur et des opioïdes (récit du patient) :
Accident du travail "en 2014" : chute d'un échafaudage "de 6 mètres" sur un chantier à Lormont, fracture d'une vertèbre lombaire, opéré "le lendemain" (arthrodèse, vis), puis "réopéré" un an ou deux plus tard parce que "ça ne tenait pas". N'a jamais repris le travail. Douleurs lombaires permanentes, cotées 6 à 7/10 au quotidien, avec une douleur dans la jambe droite "comme une décharge". Suivi au centre de la douleur de l'hôpital (Dr PUYOOU) depuis les premières années.
Tramadol après la première opération, "jusqu'à 8 par jour", pendant un an ou deux, puis oxycodone après la deuxième opération : "d'abord 2 fois 20", augmentée progressivement par le centre de la douleur et par son médecin traitant (Dr CAPDEPUY, Cenon). Patchs de fentanyl "pendant 6 mois en 2016", arrêtés car "ils se décollaient avec la transpiration" et "ça ne faisait rien de plus".
Il décrit une montée progressive des doses "sans s'en rendre compte" : la douleur revenait avant l'heure, il prenait la prise suivante plus tôt, puis "une de plus pour pouvoir bricoler". Il dit que le centre de la douleur a toujours été "réticent" et que son médecin "a fini par suivre". Les jours où il manquait, "je ne sortais pas du lit".
Actuellement, dit prendre 160 mg/j d'oxycodone (LP 80 mg x 2), "parfois une ou deux gélules rapides en plus quand ça tire". Dit n'avoir qu'un seul prescripteur, son médecin traitant, les ordonnances du CETD passant par lui. Pas d'injection, pas de sniff. Reconnaît prendre "un peu plus que prévu" certains jours et "finir la boîte avant la date", d'où le problème en janvier : "j'avais juste corrigé la date sur une ordonnance, une seule fois, la pharmacienne en a fait une affaire". Convoqué au commissariat en février, puis rappel à la loi.
Manque si retard de prise : sueurs, frissons, diarrhée, "les jambes qui ne tiennent pas en place", irritabilité. Craving surtout le matin et le soir. Tolérance nette. Beaucoup de temps passé à "gérer les boîtes".
Prégabaline (Lyrica) 150 mg x 2 "comme prescrit" par le CETD depuis 2016 environ, pour la jambe ; "ça détend", n'en prend pas plus dit-il. Ni kinésithérapie ni activité physique depuis plusieurs années ("j'ai essayé, ça me cassait le dos").
Alprazolam 0,5 mg x 3 depuis l'accident pour dormir (médecin traitant).
Nie toute surdose, malaise ou passage aux urgences en lien avec les médicaments.

Autres consommations :
Alcool : "jamais eu de problème avec l'alcool", "un verre de vin au repas, pas tous les jours". AUDIT-C à 2. Pas d'ivresse récente.
Tabac : depuis 14 ans, 20 à 25 cig/j, essais d'arrêt sans succès (une fois 3 mois "quand Séverine est née"). Toux chronique, crachats le matin, essoufflement aux efforts (un étage). Fagerström 7.
Cannabis, cocaïne, héroïne : jamais, "je ne suis pas un drogué".

Antécédents psychiatriques : aucun suivi. Reconnaît "un coup de moins bien" après l'accident, n'a "jamais vu de psy". Nie tout antécédent suicidaire.
Sommeil : s'endort tôt devant la télévision, se réveille vers 3 h "avec le dos", reprend un alprazolam. Fatigue dans la journée, sieste de 2 h.
Antécédents somatiques : fracture lombaire (arthrodèse), 2 interventions. HTA traitée (amlodipine 5 mg). Toux chronique non explorée. Ronfle "fort" selon sa femme, s'endort devant la télévision. Pas d'autre antécédent connu.
Antécédents familiaux : père ouvrier au port de Bordeaux, "il buvait, comme tout le monde à l'époque", parfois violent en paroles, jamais de soins, décédé d'un cancer à 66 ans. Un oncle maternel "mort de la boisson". Mère décédée. Une sœur cadette à Bayonne.

Biographie : né et élevé à Cenon, deuxième de deux enfants. Scolarité jusqu'à 14 ans, CAP de maçon vers 16 ans, toujours dans le bâtiment ensuite, dans la même entreprise à Lormont, devenu chef de chantier "vers 37 ans". Service

CH FICTIF DE L'ESTEY
25, allée des Fictifs
BP 70125
33998 BORDEAUX CEDEX

Tel. 05.00.00.25.00

Finess 33 0 99961 4
Siret 200 000 625 00010

FICHE D'OBSERVATIONS

HONTABAT RAYMOND — Admission A1904150028 — lun. 15/04/19 11:00 (2738 nuits) — Méd. ARRIOM - ARRIBEHAUTE OMBELINE — UFM 5208 - CSAP — UFH 5208 - CSAP

Né(e) le 12/02/1961 (65 ans) à CENON (33)
IPP 0074419362

Poids 91 kg
Taille 176 cm
IMC 29.38
SC 2.10 m²

militaire à Pau en 1980. Fier de ce parcours, parle beaucoup des chantiers ("j'ai construit la moitié de la rive droite").
Depuis l'accident : invalidité, "je suis un meuble". Litige en cours avec la CPAM sur le taux d'incapacité, audience prévue à l'automne.
Loisirs avant l'accident : pêche en Dordogne, pétanque, bricolage ; "maintenant je regarde les autres". Pas de dette, propriétaire de sa maison.
Marié depuis 1984 avec Mireille, "une sainte", aide-soignante retraitée. Une fille, Séverine, 33 ans, mariée, à Libourne. Vit avec son épouse dans une maison à Cenon. Pas d'autre antécédent judiciaire que le rappel à la loi.

Ce qu'il attend : "qu'on me laisse mon traitement et qu'on arrête de me regarder comme un tricheur", puis, en fin d'entretien, "je voudrais ne plus passer mes journées à compter". Ambivalence nette, mais demande d'aide réelle.
Examen : contact correct, un peu méfiant puis plus détendu. Tenue soignée, mains de travailleur manuel. Discours cohérent, centré sur la douleur et sur l'injustice ressentie (caisse, justice). Myosis modéré, pas de somnolence. Thymie légèrement abaissée, pas d'idées suicidaires. Pas de trouble cognitif évident. Raideur lombaire, cicatrice médiane, Lasègue droit à 50°.
Urines : opiacés négatifs, oxycodone positive, benzodiazépines positives, buprénorphine, méthadone, cocaïne, cannabis négatifs.

Synthèse : homme de 58 ans, sans antécédent addictologique déclaré, dont l'usage d'opioïdes a commencé dans un cadre médical après un accident du travail et s'est progressivement autonomisé. Trouble de l'usage des opioïdes antalgiques (oxycodone), sévère (tolérance, sevrage, perte de contrôle des doses, temps consacré, poursuite malgré les conséquences judiciaires, craving), sur douleur chronique post-traumatique du rachis. Usage de benzodiazépines et de prégabaline à préciser. Tabagisme sévère. Suspicion de BPCO et de syndrome d'apnées du sommeil.

Conclusions :
- Projet discuté : stabiliser sous traitement de substitution opioïde (méthadone, qui a aussi un effet antalgique) par une rotation en hospitalisation programmée dans l'unité d'addictologie, plutôt que de continuer à augmenter l'oxycodone. Il veut en parler à son épouse.
- Contact avec le Dr CAPDEPUY et le CETD (Dr PUYOOU), avec son accord.
- Bilan : NFS, bilan hépatique, ECG, sérologies.
- RDV assistante sociale (invalidité, litige CPAM).
- Information sur les risques de surdose (association opioïdes, benzodiazépines, prégabaline, apnées), pas de conduite après une prise supplémentaire.
- Revoir dans 3 semaines avec l'interne.

Entretien infirmier d'accueil du 15/04/2019 (Urgence : Bas)

Validé par BIROT Colette - IDE le 15/04/2019 à 11:20

Premier accueil de M. HONTABAT Raymond, 58 ans, venu seul en voiture depuis Cenon. Adressé "par la justice" : il a eu un rappel à la loi le mois dernier par le délégué du procureur, avec la consigne de "voir un centre", et il a son papier dans la poche, qu'il me montre tout de suite comme pour se justifier. Le papier parle d'une ordonnance falsifiée présentée à sa pharmacie en janvier.
Il explique qu'il prend de l'oxycodone "pour le dos" depuis son accident de chantier, qu'il a "toujours mal" et qu'il ne voit pas bien ce qu'il fait chez "les drogués", mais qu'il viendra puisqu'il faut. Ton poli, un peu raide, s'excuse beaucoup.
Constantes : TA 142/88, FC 76, SpO2 93 % en AA, poids 94 kg pour 1,76 m. Tousse gras, fume 20 à 25 cig/j depuis l'adolescence. Marche raide, se lève difficilement de la chaise.
Pas de signe de manque ni d'imprégnation ce matin (dernière prise vers 7 h).
Recueil urinaire fait. Questionnaires remis. RDV avec le Dr ARRIBEHAUTE jeudi 18/04.